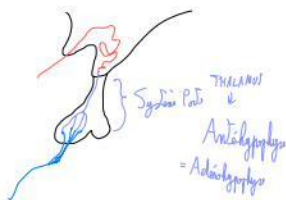


Glucocorticoids

Stress $\rightarrow$ Hypothalamus $\&$ Corticotrophin CRH



Antéhypophyse $\&$ ACTH

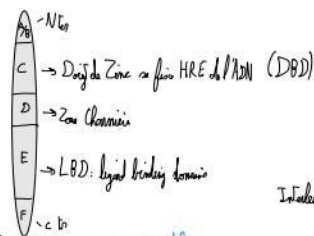
Cortic-surrénale (Zone Fasciculée)

$\&$ Cortisol

Fraction Libre (10%) ; Liée à CBG (Transcortine) / Albumine (90%)

GR (Récepteur Nucleaire aux Glucocorticoides $\rightarrow$ cytophème NON MMR)

HSP (GR) 1P
HSP ; 1P $\rightarrow$ Homodimère GR



Séquences GRE

{ GRE + : $\&$ anti-inflammatoire
GRE - : I $^+$ $\&$ pro-inflammatoire

$\&$ Annexine 1A (lipocortine) $\rightarrow$ COX-2

I $^+$ global, $\&$ Prostaglandins $\&$ Leucotriènes

Séquences NF- κ B
Pro-inflammatoire
non pro-inflammatoire

iNO Synthase = Macrophage ; Y déhibite
Macrophage

Phospholipase MMR E_{AG}^{AG}
 E_{AA}^{AG}
 E_{AG}^{AG}

$\downarrow$ PLA2 $\rightarrow$ Phospholipase A2

Acide Arachidonique (20:4:6)

COX / 5 lipo-oxygénase

Prostaglandins
Thromboxane

LTA4 (Leucotriène A4)

$\rightarrow$ LT B4 $\rightarrow$ cholestérol = atèle des $\&$ immunitaire
 $+ \text{ immuno-modulation}$

LTC4 ; LTD4 ; LTE4

Inflammation Bronchique : bronche constriction ; P.S. augmente

Autres effets : Anti-Oxidant

• Hypocalcémie

• Anti-inflammatoires (on agit pas pk)

Médecament AIS: Anti-Inflammatoire Stéroïdien

↳ Très efficace (>AINS) → traitement inflammatoire sévère (Goutte aiguë / Auto-Immune)

(E1) "Aldostérone like" → Retention Hydrosolée & Hypertension → faible p
Oxycodone → P Appétit

(INDC) Anti-inflammatoire des la fin symptômes
Jamais 2 AIS ou AIS+AINS!
Prudence enfant / vieillesse / femmes enceintes

Aucune Contre-Indication lors de la mise en jeu du pronostic vital! ... (C1) Et infection non contrôlée
infectieuses sévères

AINS

Phospholipides
↓
Phospholipase A₂ : PL A₂

Acide Arachidonique C20:4

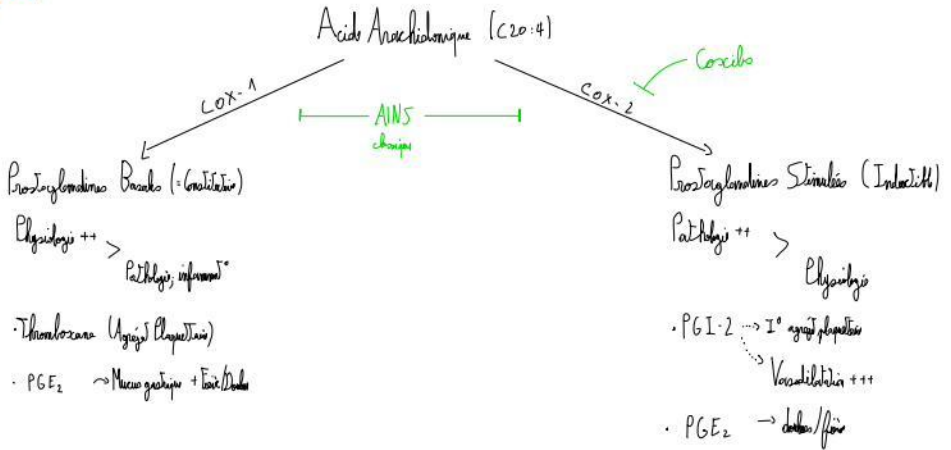
- LOX_s
Lipoxygénase
- Leucotriènes (Pneumonie)
 - HETE (inflammation cellulaire)
 - Lipoxines (Résol. Inflammation)

COX_s : Cyclooxygénases

COX-1 ou COX-2

PGG₂ → PGH₂ → Isomérisation en fonction du lieu de l'effet

Voies des Prostanoides = des dérivés de PGH₂



AINS = Inhibiteur Réversible Compétitif TOUS sauf l'Aspirine (Acide Acétylsalicylique)

- Très bonne Bioéquivalibilité (Oral > 90%)
- Bonne diffusion
 - ↳ Eau Fontaine des Plaquettes (99% Albumine ++)
- Transplacentaire na 3^{ème} trimestre
- Posttransplacental Hépatique → Elimination néon.

Effets : Antalgiques (2^{ème} effet)

Antalgiques (Dose → sup)

Anti-inflammatoires (Dose) → Modèles : V-E-Inhib.

Anti-aggrég. plaquettes (Dose)

ⓔⓁ Gastrite duodénale (mucosité → ulcère gastrique)
↳ + IPP oméprazole > 60 ans

Cardiovasculaires → THA

Rare : Atteinte Hépatique

Reins → $\downarrow$ PGE₂/PGI₂ = $\downarrow$ Vasodilatation ≈ Ischémie + IR

Jamais 2 AINS ; AINS + Vasodilat. ou Inhib. CRL